

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka · Bonus

BAŞLARKEN

Bu rehber ne işe yarar?

Klinik vakalar karşısında takılmanın nedeni çoğu zaman bilgi eksikliği değil, **sıra eksikliğidir**. Teoriyi bilirsiniz; ama belirtiler, öykü, muayene ve tetkikler aynı anda önünüze geldiğinde nereden başlayacağınızı bilemezsiniz.

Bu rehber, 210 vakayı çalışırken kullanacağınız **klinik rotayı** verir: hangi sırayla düşüneceğiniz, neye öncelik vereceğiniz ve 5 öğrenme rotasını hangi sırayla tamamlayabileceğiniz.

> **Bu rehberden sonra:** her vakaya aynı 5 adımlık yöntemle yaklaşacak, öncelikleri daha hızlı belirleyecek ve haftalık bir çalışma planınız olacak.

İçindekiler

1. Klinik akıl yürütmenin 5 adımı
2. Öncelikleri belirleme
3. Ayırıcı tanıyı sistemli kurma
4. 5 rotayı hangi sırayla çalışmalı?
5. Bir vakayı 25 dakikada çalışma rutini
6. Sık yapılan hatalar
7. Haftalık kontrol listesi

BÖLÜM 1

Klinik akıl yürütmenin 5 adımı

1. **Problem listesi çıkarın.** Başvuru nedeni, öykü, muayene ve tetkiklerdeki her anormal bulguyu ayrı bir madde olarak yazın. Henüz tanı koymayın.
2. **Problemleri gruplayın ve önceliklendirin.** Birbiriyle ilişkili bulguları bir araya getirin (ör. poliüri + polidipsi + düşük idrar dansitesi). En spesifik ve en tehlikeli problemi başa alın.
3. **Lokalize edin.** Sorun hangi sistemde ve hangi düzeyde? (ör. alt mı üst idrar yolu mu; periferik mi santral vestibüler mi; prehepatik, hepatik veya posthepatik ikter mi?)
4. **Ayırıcı tanı listesi kurun.** Lokalizasyona göre, sistemli bir yöntemle (Bölüm 3) olası nedenleri sıralayın; en olası ve en tehlikeliyi işaretleyin.
5. **Tanı ve tedavi planı yapın.** Her tetkikin hangi hipotezi doğrulayacağını veya dışlayacağını bilin. Sonra vakanın yorumlu çözümüyle karşılaştırın.

Altın kural: Tetkik istemeden önce «Bu sonuç benim kararımı nasıl değiştirecek?» diye sorun. Kararı değiştirmeyecek tetkik, öncelikli değildir.

BÖLÜM 2

Öncelikleri belirleme

Her vakada önce hayatı tehdit eden durumu, sonra sık görüleni, en son nadir olanı düşünün.

Öncelik	Soru	Örnek
1 · Hayati tehdit	Hava yolu, solunum, dolaşım (ABC) stabil mi?	Şok, dispne, hiperkalemi, GDV, üretral tıkanma
2 · Zaman duyarlı	Gecikme sonucu değiştirir mi?	Zehirlenme (dekontaminasyon), açık kırık, piyometra
3 · Sık görülen	Bu tür, yaş ve ırkta en sık neden ne?	Genç aşısız köpekte kanlı ishal → parvovirüs
4 · Nadir ama önemli	Atlarsam ne olur?	İhbarı zorunlu hastalıklar, zoonozlar

Sinyalman (tür, yaş, ırk, cinsiyet) neden önemlidir?

- **Tür:** kedide parasetamol, köpekte ksilitol, atta tetanoz duyarlılığı.
- **Yaş:** yavrularda konjenital ve enfeksiyöz, yaşlılarda neoplastik ve dejeneratif nedenler.
- **Irk:** Dachshund'da disk, Doberman'da DKM, çoban ırklarında MDR1.
- **Cinsiyet ve üreme durumu:** kısırlaştırılmamış dişide piyometra ve meme tümörü, erkekte prostat.

BÖLÜM 3

Ayırıcı tanıyı sistemli kurma

Ayırıcı tanıda bir şeyi unutmamak için mekanizmaya dayalı bir kontrol listesi kullanın. En bilinen yöntem **DAMNIT-V**'dir:

Harf	Mekanizma	Aklınıza gelmesi gerekenler
D	Dejeneratif / Gelişimsel	Disk hastalığı, osteoartrit, konjenital anomaliler
A	Anomali / Otoimmün	Portosistemik şant, IMHA, ITP, poliartrit
M	Metabolik	Diyabet, Addison, hipotiroidizm, hipokalsemi
N	Neoplazi / Beslenme	Lenfoma, hemanjiyosarkom, beslenme eksiklikleri
I	İnflamatuvar / Enfeksiyöz / İdiyopatik / İyatrojenik	Bakteriyel, viral, paraziter; ilaç etkileri
T	Travma / Toksik	Kaza, ısırık, zehirlenmeler
V	Vasküler	Tromboemboli, iskemi, kanama

> Listeyi yazdıktan sonra her maddenin yanına «lehine» ve «aleyhine» bulguları ekleyin. Vakanın yorumlu çözümünde hangi bulgunun belirleyici olduğunu kontrol edin.

BÖLÜM 4

5 rotayı hangi sırayla çalışmalı?

Rotalar bağımsızdır ama aşağıdaki sıra, temel akıl yürütmeden karmaşık durumlara doğru ilerler:

Hafta	Rota	Vaka	Odak
1–2	01 · Küçük Hayvanlar ve Klinik Akıl Yürütme	001–040	Problem listesi ve lokalizasyon alışkanlığı
3–4	02 · Tetkikler ve Tanısal Yorumlama	041–095	Hemogram, biyokimya, idrar, sitoloji, görüntüleme
5	03 · Acil Durumlar, Toksikoloji ve Anestezi	096–135	Öncelik belirleme ve stabilizasyon
6	04 · Cerrahi, Üreme ve Neonatoloji	136–170	Karar zamanlaması, doğum ve yeni doğan
7–8	05 · Büyük Hayvanlar, Üretim, Egzotikler ve Halk Sağlığı	171–210	Sürü düşüncesi, zoonozlar ve mevzuat

Sınava hazırlanıyorsanız: sınav konusuna denk gelen rotayla başlayın, sonra Rota 02'den ilgili tetkik vakalarını ekleyin.
Staja hazırlanıyorsanız: Rota 03 ile başlayın; klinikte ilk karşılaşacağınız şey önceliklendirmedir.

BÖLÜM 5

Bir vakayı 25 dakikada çalışma rutini

Süre	Ne yapılır?
0–5 dk	Hasta, başvuru nedeni ve öyküyü okuyun. Problem listesini yazın.
5–10 dk	Muayene ve ek bulguları ekleyin; problemleri gruplayın ve lokalize edin.
10–17 dk	«Klinik durak»ta durun: 3 analiz sorusunu yanıtlayın, ayırıcı tanı listenizi yazın.
17–22 dk	Yorumlu çözümü okuyun; kendi cevabınızla farkları işaretleyin.
22–25 dk	«Akılda tutulacak noktalar»ı Klinik Pekiştirme Defteri'ne kendi cümlelerinizle geçirin.

> Günde 2 vaka = 15 haftada 210 vaka. Günde 4 vaka = yaklaşık 8 hafta.

BÖLÜM 6

Sık yapılan hatalar

- **İlk bulguya kilitlenmek:** «Ateş var, enfeksiyondur» deyip diğer bulguları görmezden gelmek. Önce tüm problem listesini yazın.
- **Tek bir sayıya göre karar vermek:** tek bir yüksek glukoz değeri diyabet demek değildir; laboratuvar her zaman klinikle birlikte yorumlanır.
- **Normal sonucu «sorun yok» sanmak:** akut kanamada hematokrit ilk saatlerde normal olabilir.
- **Sinyalmanı atlamak:** tür, yaş ve ırk ayırıcı tanıyı büyük ölçüde daraltır.
- **Çözümü erken okumak:** klinik durakta durmadan çözüme bakmak öğrenmeyi azaltır.
- **Hasta yerine sadece hastalığa bakmak:** ağrı, beslenme ve sahibin olanakları da planın parçasıdır.

BÖLÜM 7

Haftalık kontrol listesi

- ☐ Bu hafta çalışacağım rotayı ve vaka aralığını belirledim.
- ☐ Her vakada önce problem listesi yazdım.
- ☐ Klinik durakta durup kendi hipotezlerimi yazdım.
- ☐ Yanlış yaptığım vakaları işaretledim.
- ☐ Akılda tutulacak noktaları deftere geçirdim.
- ☐ Hafta sonunda işaretli vakaları tekrar çözdüm.
- ☐ Bir vakayı yüksek sesle sunmayı denedim (Bonus 03).

Sonraki adım: Rota 01'in ilk 5 vakasını bu rehberdeki 5 adımla çözün ve sonuçlarınızı Klinik Pekiştirme Defteri'ne yazın.